Escanea este código para ingresar directamente a tu resultado

Clínica del Country

Bogotá, 7/04/2026

NOMBRE: CARDONA MORENO,RODRIGO
IDENTIFICACION: 8277965CC
FECHA DE NACIMIENTO: 24/07/1947
SERVICIO:
DOSIS:

Reporte:

TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES (PET-CT) CON F18-FDG

Radiofármaco: F-18 FDG.
Actividad administrada: 6.1 mCi.
Glucosa sérica: 85 mg/dl.
Medio de contraste oral:Agua1.500 ml.
Tiempo de ayuno: > 6 horas.
DLP: 997 mGy.cm

Datos e Indicación Clínica: Sindrome adenomegálico con LDH aumentada. Sintomas B. Estudio de extensión.
Estudios previos: No cuenta con estudio 18F- FDG PET/CT previo para comparar.

Técnica: 75 minutos después de la administración intravenosa del radiofármaco en el antebrazo derecho se adquirieron imágenes de cuerpo entero, en un equipo PET/CT Siemens Biograph Vision 450 (digital). Se siguió un protocolo de CT diseñado para corrección de atenuación y localización anatómica de las alteraciones metabólicas: no reemplaza los protocolos para regiones corporales específicas habitualmente empleados en CT diagnóstico.Se proporciona el valor estandarizado de captación (SUV) máxima de las lesiones dominantes normalizado al peso del paciente.

Hallazgos principales:
SUVmax de pool sanguíneo: 1.5, SUVmax del hígado: 3.7, SUVmax del bazo: 5.7

Cabeza: Se aprecia actividad metabólica de aspecto usual en el parénquima cerebral.

Cuello: Adenopatías hipermetabólicas a nivel supraclavicular bilateral de predominio del lado izquierdo con SUVmax hasta de 10.3 y de 11x 18 mm. Foco hipermetabólico en el aspecto

posterior del cartílago tiroides del lado derecho (SUVmax: 4.2). Glándula tiroides sin lesiones hipermetabólicas.

Tórax: Múltiples adenopatías hipermetabólicas mediastinales de localización prevascular, paratraqueal, subaórtico, subcarinal e hiliar bilateral, siendo las dominantes a nivel subcarinal (SUVmax: 11.9) de 21 mm de eje corto, hiliar derecho (SUVmax: 11.1) de 27 mm. También ganglios paraaórticos, paraesofágicos de forma bilateral y en la cadena mamaria interna bilateral. Escasos ganglios axilares con ligero aumento del metabolismo, del lado izquierdo con SUVmax de 2.1 y 5 mm.
Derrame pleural principalmente izquierdo. Múltiples nódulos pulmonares sólidos bilaterales, algunos de localización subpleural, con incremento del metabolismo glicolítico, destacando uno en el segmento apical del lóbulo superior derecho (SUVmax: 13.5) de 17 mm de diámetro mayor, segmento anterior del lóbulo superior derecho (SUVmax: 14.6) de 22 mm, segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo (SUVmax: 12.2) de 16 mm.

Abdomen y pelvis: Aumento difuso del metabolismo en el parénquima esplénico, identificando una lesión hipermetabólica en el borde superior del polo superior del bazo (SUVmax: 25.6) de aproximadamente 42x 46 mm. Bazo de 11.2 cm de longitud. Hígado de 16 cm (línea medio clavicular) sin alteraciones metabólicas. Glándulas adrenales, páncreas y riñones sin lesiones focales hipermetabólicas. Múltiples ganglios y conglomerados ganglionares hipermetabólicos en el hilio hepático, retrocrural, periesplénico (SUVmax: 26.7, de 23 mm), gastrohepático, peripancreático (SUVmax: 20.7), interaortocavo, precavo, paraaórtico, También en el mesenterio, estando la dominante a nivel de flanco izquierdo 28x 39 mm, SUVmax de 13.7, además ganglios a nivel iíaco común derecho.

Músculo-esquelético: Se observan múltiples lesiones óseas hipermetabólicas diseminadas de forma difusa en el esqueleto axilar y apendicular, en su mayoría de aspecto lítico y otras sin representación morfológica en el CT de baja dosis; se cita algunas dominantes: tercio proximal del húmero derecho, clavicula derecha, esternón, escápulas, arcos costales; de estos se acompaña con lesión de tejidos blandos en el aspecto anterior del tercer arco costal derecho, la segunda unión costovertebral derecha (SUVmax: 9.3), fractura del aspecto posterior del onceavo arco

Bogotá, 7/04/2026

NOMBRE: CARDONA MORENO,RODRIGO
IDENTIFICACION: 8277965CC
FECHA DE NACIMIENTO: 24/07/1947
SERVICIO:
DOSIS:

costal derecho. También hipermetabolismo en el aspecto derecho de C1 (SUVmax: 6.5), apófisis espinosa de C2, múltiples cuerpos vertebrales, sacro, ilíacos (SUVmax: 7.7), tercio proximal de ambos femures, y tercio medio del fémur derecho (SUVmax: 7.9).

OPINIÓN:

- **ESTUDIO PET/CT 18F-FDG QUE MUESTRA MÚLTIPLES GANGLIOS HIPERMETABÓLICOS TUMORALES SUPRA E INFRADIAFRAGMÁTICOS.**
- **LESIÓN HIPERMETABÓLICA EN EL BAZO SOSPECHOSA DE INFILTRACIÓN NEOPLÁSICA.**
- **COMPROMISO METASTÁSICO PULMONAR Y ÓSEO.**
- **OTROS HALLAZGOS PET Y EN CT DE BAJA DOSIS (NO DIAGNÓSTICO): VER DESCRIPCIÓN.**

Nota de exención: Las lesiones < 3.2 mm están por debajo del límite de resolución espacial del PET; para aquellas que miden entre 3.2 y 7 mm la sensibilidad de detección es menor (entre el 50% y el 80%) que para aquellas > 7 mm. Algunos procesos inflamatorios (especialmente granulomatosos), post quirúrgicos, traumáticos pueden tener alta captación de FDG (falsos positivos para malignidad). Neoplasias bien diferenciadas o con bajo nivel proliferativo son detectadas con menor sensibilidad.

Atentamente,

NATHALIE HERNANDEZ HIDALGO
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR
Registro Médico: 1016011424